

Fecha Última Actualización: 31-08-2022 1:05:56

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Rosa Ester Reyes Díaz	Rut : 4.264.160-K	N° Archivo : A030343	N° Epicrisis
Edad : 82a 5m 13d	Fecha Nacto : 18/03/1940	Sexo : Femenino	321209
Dirección : Los Ruise Ores 0649, Pob Los Andes	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 7390 1166	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)	Fecha Ingreso : 19/08/2022	19:09	Días Estadía : 12
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 31/08/2022	01:08	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Postoperatorio hernioplastia abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Rosa Reyes Díaz
RUT: 4264160-K
Edad: 82 años
FI CASR: 19.08.22
FI UTIM: 22.08.22
FI PAM: 23.08.22
FI UCI: 24.08.22

II. Antecedentes:

Médicos: HTA, FA, tr. del ánimo
Fármacos: Losartán, amlodipino, sertralina
Quirúrgicos: Hernia Spiegel, herniorrafia con malla
Alergias: No a fármacos
Hábitos: TBQ (refiere suspendido, aunque IPA > 30), OH niega, Drogas niega
Inmunizaciones: COVID 2 dosis (no quiere completar esquema) + Flu (2022)

III. Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos, ingresa de manera electiva a realizarse TAR (transversus abdominis release) bilateral por hernia de línea media incisional. Se realiza el 19/08, se describe en protocolo intenso proceso adherencial de asas a saco herniario y se describe procedimiento a izquierda laborioso debido a pérdida de planos por proceso cicatrizal en relación a hernia de la línea semilunar, que se logra reducir completamente, sin incidentes reportados. Egresos con 3 drenajes. Se describe intolerancia a la alimentación inicial, con náuseas y emesis. Destaca en evolución a las 48 horas req. de O2 al alza, con 4L por NRC, polipneica y FA con RVR de hasta 130 lpm. El día 21/08 PM presenta franco deterioro, con req. de CNAF (60/40 L/FiO2); es evaluada por medicina, se solicita AngioTC en que no se visualiza TEP, se observa leve derrame pleural bilateral, atelectasias segmentarias bibasales y subsegmentarias en lóbulos superiores, y opacidades parenquimatosas sugerentes de edema alveolar, con acentuada cardiomegalia. En ese contexto se solicita traslado a UTIM.

En UTIM evoluciona con deterioro clínico e inestabilidad hemodinámica, asociado a FA con RVR manejada con amiodarona y deterioro de mecánica ventilatoria requiriendo IOT en SRI, asociado a hipertensión abdominal por medición de PIA. TAC TAP control inicialmente sin signos de perforación. Dado deterioro clínico importante, se define Laparotomía exploradora,

Fecha Epicrisis : 31/08/2022 01:05

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 31-08-2022 1:05:56

Página 2 de 3

evidenciando perforación yeyuno a 10 cm de ángulo de Treitz. Se realiza aseo quirúrgico y se intenta cierre primario con gasa testigo y bolsa de Bogotá.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UPC:

1. Shock séptico + FOM (hemodinámica, respiratoria, renal, hepática, hematológica). SOFA 11 - APACHE II 31
- a. Foco abdominal: peritonitis secundaria a perforación yeyuno proximal
- i. Hipertensión abdominal (PIA 17)
- ii. Postoperatorio día 1 Laparotomía exploradora + cierre primario asa + bolsa Bogotá.
2. Hernia Spiegel atascada -> hernioplastía + malla aponeurótica 19/08.
3. Falla renal aguda KDIGO III
4. Insuficiencia respiratoria aguda parcial -> Obs SDRA vs ICC descompensada
5. Injuría hepática aguda por sepsis
6. FA con RVR
7. Antecedentes: obs LCFA vs EPOC, ICC FEp.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN EN UPC:

Ingresa en profundo shock séptico foco abdominal + Falla multiorgánica (hemodinámica, renal, hepática, coagulopatía), con req NA + AD en dosis altas. Se reanima inicialmente, con buena respuesta y disminución progresiva de requerimientos de DVA. Se maneja sepsis inicialmente con esquema de segunda línea (Imipenem + Vancomicina), que posteriormente se decala Ceftriaxona y se mantiene Vancomicina por microbiología sensible.

De lo quirúrgico, ingresa a laparotomía exploradora el 26/08 donde se visualiza isquemia en sitio de perforación yeyunal, en íleon distal y colon derecho. Se realiza extracción de áreas isquémicas, dejando asas cerradas en el interior del abdomen + instalación Abthera. Posterior a pabellón, evoluciona estable, con abdomen abierto.

Se decide en conjunto con equipo de cirugía y familia nueva laparotomía exploradora para evaluar posibilidades de anastomosis y cierre de pared abdominal. Procedimiento realizado el 30/08, donde se visualiza isquemia intestinal generalizada, con 30 cm de intestino viable en intestino delgado; por lo que se decide cierre de pared abdominal y limitación de esfuerzo terapéutico por parte de cirugía conversado con familiares.

Reingresa a UPC en malas condiciones generales, NA a 0.1 ug/kg/min. Evolucionando con deterioro hemodinámico progresivo. Fallece el 31/08 a las 00:30 hr. Se da aviso a familiares y se entrega certificado de defunción.

DIAGNÓSTICOS DE FALLECIAMIENTO

Shock séptico foco abdominal + Falla orgánica múltiple
Peritonitis aguda
Perforación yeyuno proximal
Isquemia intestinal

Diagnóstico de Egreso

PERFORACION DEL INTESTINO (NO TRAUMATICA) -
CHOQUE SÉPTICO -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece el 31/08/22 a las 00:30 hr.

Se emite certificado de defunción y se entrega a familia.

Plan Post Alta

Cuerpo a Anatomía Patológica

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Fecha Epicrisis : 31/08/2022 01:05

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 31-08-2022 1:05:56

Página 3 de 3

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Tomás Lahera Frohmann
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 31/08/2022 01:05

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:44

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar